

1969

~~secreto~~

martedì 18 novembre ore 14,15 - 16'30.

Gruppo: Greco - Piatti - Barberis - Sperone

V All'entrata troviamo la madre di un ragazzo di 27 anni ricoverato al 17 da 8 giorni circa (è già stato ricoverato a più riprese, prima era al 15, era stato picchiato dagli infermieri in seguito a un gesto di rabbia - rotto televisione - madre lamentatasi con ^{Bob} Morra in presenza di un testimone amico famiglia, il ragazzo era stato e cambiato di reparto ma nessun seguito giuridico nè rapporto da parte del Direttore).

Andiamo al reparto 6: (reparto chiuso) ci accoglie un infermiere gentilmente, se ne accoda poi subito un altro.

Il reparto ha 130 degenti attualmente e 18 infermieri più un medico (Dr. Valero)

Gli infermieri di turno sono circa 6 di giorno e 3 di notte.

Una parte di malati (in totale 40) lavorano in campagna, altri giardinaggio, 3-4 in lavanderia, altri hanno mansioni saltuarie nel reparto (lavage vetri ecc.). I lavoratori sono già usciti, i malati che restano sono per lo più nell'entrata (parlatorio) chi passeggia avanti e indietro, chi dorme appoggiato ai tavoli o sdraiato sulle panche.

Nella sala successiva c'è il refettorio, dopo ancora un dormitorio adibito a infermeria, c'è un solo malato a letto.

Li vicino c'è l'unico bagno (1 vasca più 2 docce) dove i malati si alternano al pomeriggio. La stanza da bagno è chiusa a chiave.

Piano di sopra: ci sono 3 dormitori enormi, letti molto vicini, ognuno ha il suo comodino e basta, nel corridoio lavandini con sola acqua fredda, pulizia estrema in tutto il reparto.

Al piano di sopra ancora, atelier di pittura di recente creazione: ^{Sig.ra Chena} l'insegnante viene due volte la settimana. La scelta dei malati per partecipare all'atelier è stata decisa dagli infermieri (non si sa in base a quali criteri) ~~reparto di età più giovani~~, generalmente i prescelti hanno accettato (gruppetto di 7-8). Alcuni malati non erano neppure a conoscenza dell'esistenza dell'Atelier!!.

Una psicologa è venuta 5-6 volte per tenere un corso agli infermieri (Bertalotti), poi non è più venuta perchè ha avuto problemi con la amministrazione (a detta di un infermiere)/

L'assistente sociale viene ma abbastanza di rado in quanto ha molti altri reparti.

Qualche mese fa erano venuti 2 studenti come volontari, pare si siano tenute 2-3 assemblee di reparto coi malati, poi hanno avuto un colloquio col medico del reparto, dopo di che non si sono più fatti vedere (non sono stati precisati i motivi).

Le riunioni si tengono tra medico e infermieri soltanto, gli infermieri non sembrano sentire la necessità di una partecipazione dei malati nè il medico sembra favorire un lavoro in tal senso.

I malati possono uscire dal reparto per andare in cortile o al bar ad es. solo su permesso del medico del reparto: un malato abbastanza lucido, ex operaio metallurgico, ci dice che avendo chiesto al dottore il permesso di uscire dal reparto questi gli ha risposto che poteva uscire se andava a lavorare, e dato che lui non si sentiva ancora di lavorare niente permesso (è poi riuscito ad ottenerlo con molte insistenze ed altri mezzi). Il bar è aperto solo nel primo pomeriggio verso le 7 di sera, e solo 4 giorni alla settimana.

La attività dei malati che non lavorano fuori reparto sono minime o inesistenti, a parte la T.V., (e l'atelier di pittura), giocano a carte, per lo più però restano inattivi. I più evoluti chiedono libri dalla biblioteca, non tutti hanno i soldi per comperarsi il giornale, gli infermieri avrebbero risposto che tanto glieli portano i parenti. Un malato raccoglie il tabacco delle cicche per poi venderlo ad altri malati e fare qualche lira.

Non si tratta di malati "lunghissimo degenti" il minimo si aggira però sui 10 mesi - 12 mesi (però frequenti rientri), gli anziani ~~non~~ sono ~~moltissimi~~, forse il 30-40% (a occhio).

vi sono diversi casi definiti "schizofrenici", con fissazioni religiose o di altro tipo, generalmente sono tranquilli.

Il medico pensa di aprire in futuro (quando?) il reparto, uno degli infermieri si dice contrario all'eliminazione delle inferriate, prima di aprire il reparto - dice - bisogna però preparare i malati (come?). Al momento nessun tipo di terapia viene applicata nè di gruppo nè individuale: solo medicine (tipo Serenase, in qualche caso). L'impressione dominante è di inattività, abbandono a se stessi dei malati che non comunicano tra loro (ciò è stato confermato dagli infermieri), pur essendo molti di essi in grado di ragionare e parlare, cioè di farlo.

Sembra che gli infermieri trovino ciò normale o comunque senza rimedio. Indumenti: sono stati ordinati degli armadi per mettere gli oggetti personali, i malati hanno la divisa, per lo più quella vecchia (tuta blu), alcuni il proprio vestito, alcuni la divisa nuova (cachi) che però viene data a quelli che si sporcano meno (cioè a pochi, quasi fosse un premio).

Diversi malati non hanno la cintura ai pantaloni ma un legaccio di stoffa: solo i più tranquilli la possono usare.

Quando entriamo i malati non si fanno avanti, ci guardano, al massimo rispondono al nostro saluto.

Non è stato possibile parlare coi malati (anche dopo) senza che uno o due infermieri accorressero e presenziassero al dialogo (aria di controllo, essi stessi molto difesi).

Allyce
Patricia Sproule

21 novembre 1969 - martedì - ore 13.30
Barberis, Greco, Piatti, Sperone

↑ Nato

Vf

Incontro davanti all'ospedale con la signora Marianna Martone Sais, madre di un ricoverato nell'O.P. di Collegno.

Descrizione delle difficoltà per curare a casa il figlio; obbligo poi di ricoverarlo con conseguenze sempre peggiori. Racconto delle percosse subite dal figlio (un ragazzo di 25/30 anni) pochi mesi or sono; (forse verso il mese di giugno/luglio) pare che il ragazzo avesse chiesto agli infermieri che stavano davanti alla televisione, a vedere Patty Pravo, di dargli qualche rimedio perché si sentiva male. Questi invece di ascoltarlo sembra gli abbiano risposto male o lo abbiano schernito. A questo punto il Sais si sarebbe lanciato contro il televisore spaccandolo e avrebbe dato in escandescenze; gli infermieri dopo averlo immobilizzato l'hanno messo a letto e contenuto mani e piedi e poi, a' avrebbe duramente percosso ^{aperti} e colpi di chiavi un po' dappertutto. La madre ha saputo ogni cosa il giorno successivo dal figlio stesso e ha potuto constatare di persona i segni dei colpi; ha protestato energicamente col dr. Mossa. Mossa ha fatto chiamare gli infermieri che erano nel reparto al momento del fatto ma costoro hanno negato. Infine, di fronte alle accuse precise della madre, pare che abbiano parzialmente ammesso, ma si sono giustificati con lo stato di necessità e poi hanno chiesto di non dare loro delle grane ecc. Comunque la signora Sais non ha più saputo nulla e non le risulta che gli infermieri siano stati puniti.

in sala d'attesa -
cattivi un pietoso
do -

Ingresso senza difficoltà.

X REPARTO 6 -

Ci accoglie gentilmente un infermiere che ci fa entrare subito appena ha capito che ^{siamo} della Commissione. Poi rimarrà sempre con noi; anzi ne arriveranno parecchi altri e non sarà praticamente possibile parlare con i malati da soli.

Dal colloquio con gli infermieri capisco molto poco; sembrano gentili con i degenti e decisi a migliorare le cose nel reparto. Ma non posso rendermi conto delle loro vere intenzioni. Emerge la decisione di aprire il reparto, però uno non è d'accordo sul togliere le inferriate (chissà perché?), un altro non vuole assolutamente le Assemblies (scoprirò che anche il medico del reparto dr. Vallero è contro l'Assemblea), altri non hanno opinioni ben precise. E' chiaro che non hanno avuto nessuna preparazione per affrontare il discorso della Comunità Terapeutica, anzi sono abbastanza prevenuti. Un infermiere alto e grosso, dice ridendo che il medico non vuole le Assemblies perché è roba di "sinistra". Comunque l'impressione è di un gruppo di persone con le quali si potrebbe forse ottenere qualcosa, ma sarebbe necessario lavorare con loro a lungo.

Pare che sia stata allestita una camera dove i malati possono disegnare e dipingere, ma parlando con un degente quando questi mi dice di amare il disegno, scopro che non sa nulla della camera dove potrebbe

disegnare. Evidentemente non era giudicato adatto dagli infermieri. L'infermiere che ^{mi}sente chiedere perché quel malato non ~~sapeva~~ della possibilità di dipingere ecc. dice che non ~~era~~ ancora stato avvertito perché la cosa ~~era~~ molto recente.

In sezione ci sono 135 degenti, e 140 letti. Dormitori grandi, con poco spazio per ciascuno, senza armadietti ecc. Stanzone squallidi, tetri, con sbarre alle finestre, porte chiuse a chiave. Tavoli lunghissimi, panche e basta. I malati sono vestiti, anzi in fagottati con roba dell'ospedale, appaiono trascurati, solitari, apatici e abbandonati.

Pochi danno segno di interessarsi a noi. Eppure non appaiono particolarmente regrediti e neppure vistosamente ammalati. Sono taciturni e come età media circa sui ⁴⁰50 anni. In uno degli stanzoni dove stanno ammucchiati vi è un lavandino per urinare, piazzato proprio in mezzo ad un muro, senza neppure una quinta di muro per celarlo.

Televisore. Nessun giornale o altri elementi di svago.

In tutto il reparto 2 docce, 1 vasca da bagno (però mi ha detto l'infermiere ^{che} il bagno non viene adoperato: si usano le docce perché più pratiche, veloci ed igieniche.) Ogni degente fa la doccia circa ogni 15/20 giorni. Anche il cambio della biancheria del letto avviene ogni 20 giorni e talvolta anche 25. (*1 val mese*) -

I degenti sono tutti in sezione anche se fuori ~~è~~ è una giornata bellissima, sebbene fredda. Pare che non abbiano vestiti per coprirsi e tanto meno cappotti pesanti, così finiscono per non uscire mai.

Un malato è a letto contenuto per un braccio. Pare che lo chieda lui. (?)

Ho parlato con due malati, ma in presenza degli infermieri. Non hanno detto nulla di rilevante. Uno ha dichiarato di essere stato portato in mani comio direttamente dal CIM: il medico l'ha ingannato dicendogli di aspettare un momento ^{che si avrebbe dato la risposta} ~~per una risposta~~ ^{per qualche ora} e invece è arrivata l'autoambulanza che l'ha portato a Collegno. E